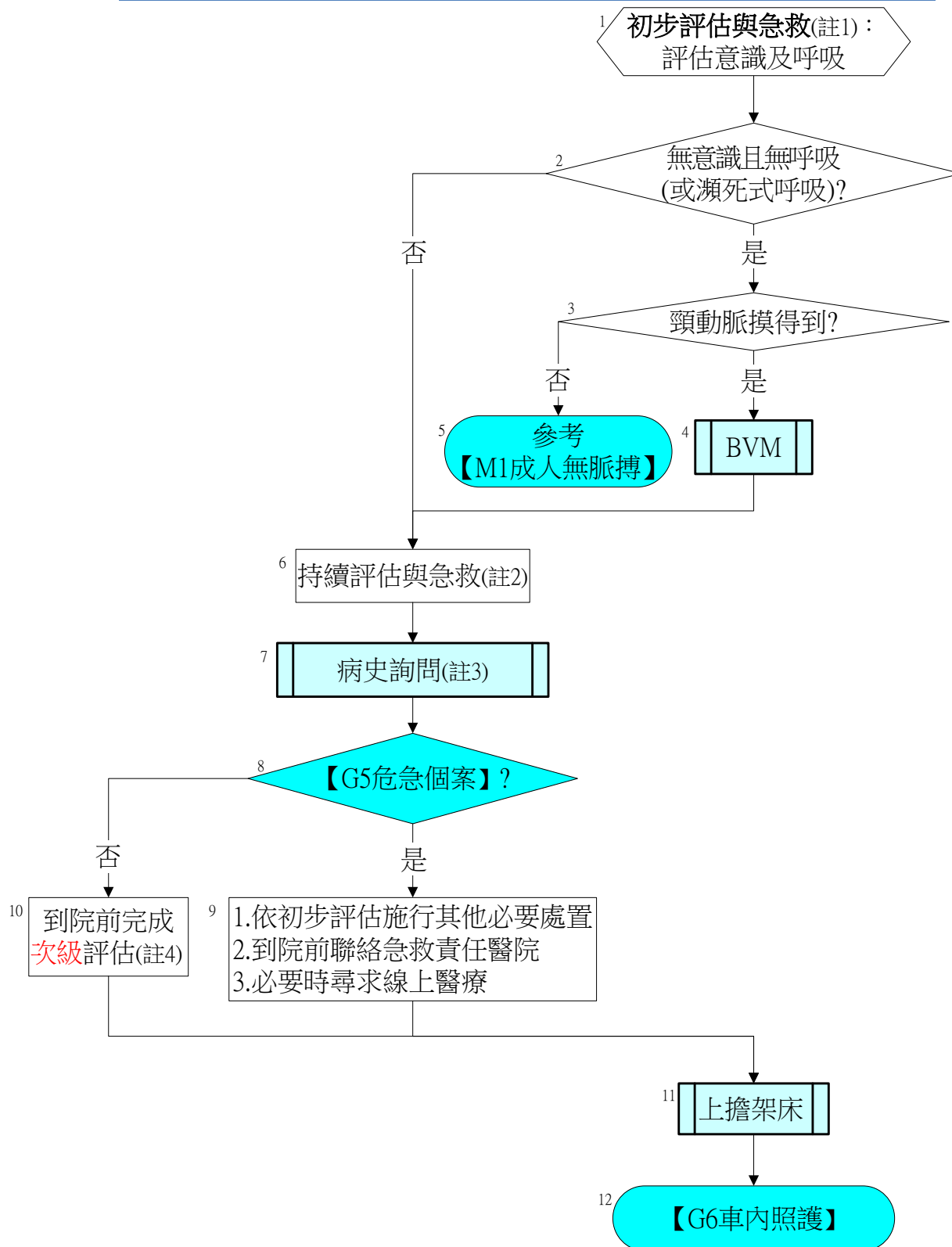


G3 非外傷

程 序



要 旨

- 一、非外傷病人救護作業程序，首重經由病人評估辨認出瀕死徵象及危急個案（ALS個案）。
- 二、因為危急個案有較高的可能性發生到院前心跳停止，故救護員於現場或車上處置此類病人的同時，須更加注意瀕死徵象的發生，以儘早開始必要的急救。

註 解

註1>

一、評估呼吸道（A）：

以看與聽的方式評估呼吸道是否有阻塞之現象。如不暢通，以壓額抬下巴法打開呼吸道，必要時給予口咽、鼻咽輔助呼吸道或進階呼吸道。打開呼吸道之時若發現嘴巴內有可見的異物或嘔吐物應先將其去除。若嘔吐物或分泌物會影響呼吸則應進行抽吸。呼吸道與呼吸應同時評估，且評估時間合計不超過10 秒。

二、評估呼吸（B）：

以看與聽的方式評估有、無呼吸或瀕死式呼吸；若有呼吸，應評估呼吸品質（深淺、快慢）、是否使用呼吸輔助肌、膚色發紺。視情況給予氧氣治療並檢測SpO₂（參考【M2呼吸困難】）。

三、評估脈搏、循環品質（C）：

（一）無意識之病人：

- 1、成人：檢查頸動脈（評估時間不超過 10 秒）。
- 2、兒童：檢查頸動脈或股動脈（評估時間不超過 10 秒）。
- 3、嬰兒：檢查股動脈或臂動脈（評估時間不超過 10 秒）。

（二）有意識或意識不清之病人檢查 2 側橈動脈(兒童及嬰兒則檢查上項動脈點)，並評估周邊循環(目視膚色是否蒼白、發紺或異常，觸摸末端肢體是否濕冷，檢查微血管充填時間是否 ≥ 2 秒)。

（三）血壓、SpO₂：測量血壓及血氧濃度。

註2>

- 一、病人有適當呼吸時，持續評估循環及輔助檢查。
- 二、輔助檢查包括(視情況量測)量測體溫、量測血糖、瞳孔大小、聽診肺音及到院前中風

指標等。

三、到院前救護時，遇無脈搏病人應儘速使用AED執行分析，其餘時間盡量保持不間斷的壓胸，其次才考慮置入進階呼吸道。若病人已被貼上PAD之AED貼片，無論之前是否接受電擊，均視同剛貼上貼片來執行操作。總結來說，無論使用消防局或PAD之AED，上車前EMT應給予2次之分析，於第二次分析之後依照AED指示動作後（電擊或不電擊），考慮運送病人離開現場。

註3>

一、到達現場時除自我介紹外，若病人清醒應詢問病人「哪裡不舒服？」，評估呼吸道及呼吸狀況。若病人無回應，則應詢問家屬或旁人「剛剛發生何事？」以了解其求救原因，並根據其求救原因（如呼吸心跳停止、呼吸困難、胸痛或癲癇…等）給予適當處置，至於病史詢問，可包括現病史。

（一）主訴：除哪裡不舒服外，應再詢問怎麼不舒服及不舒服有多久？

（二）之前：求救之前在做什麼事？

（三）吃：最近一次進食的時間？

（四）過：過去病史？

（五）藥：平時有無服用何種藥物？

（六）敏：有無對食物或藥物等過敏的病史？

（七）感：除主訴外還有其他不舒服嗎？

二、現病史：

（一）Onset/Origin：症狀的發生當時狀況。

（二）Provoke/Palliation：有無加劇或緩解此一症狀的因素。

（三）Quality：性質。

（四）Region/Radiation：位置以及有無轉移。

（五）Severity：嚴重度。

（六）Time/Duration：持續時間與頻率。

三、病史應在初步評估的同時詢問，但不可影響評估及處置之進行，EMT應在彼此合作下完成初步評估及病史詢問。

註4>

次級評估

一、非危急個案的二度評估應在現場執行；而危急個案（ALS）之次級評估原則上應在救

護車上實施，若時間允許，始得在現場執行。

二、非外傷次級評估：

(一) 生命徵象評估：意識（GCS）、呼吸、脈搏、血壓、瞳孔、體溫、膚色及血氧濃度。

(二) 重點理學檢查：

比較二側上肢和下肢的感覺和運動功能、氣管是否偏移、頸靜脈是否怒張或塌陷、呼吸時胸部起伏是否對稱、聽診兩側肺音、腹部視診是否有腫脹和觸診是否有壓痛、上或下肢是否水腫或浮腫、全身皮膚是否有異常(紅疹、紫斑或針孔等)。